

בחירת וריד פריפרי

היתרונות

- גישה נוחה ויעילה לווריד בזמן ההחייאה
- אינו מצריך הפסקת החייאה כדי לבצע
- נדרשת פחות מיומנות מווריד מרכזי
- פחות סיבוכים יחסית לווריד מרכזי
- שוטפים כל תרופה ב-20 סמ"ק ולאחר מכן מרימים את האיבר

החסרונות

- נמצא בתמט במצב הלם
- דלקות בווריד נפוצות יחסית
- לשימוש בייחוד לתמיסות איזוטוניות, תמיסות היפרטוניות גורמות לכאב ולדלקות
- נדרשות לתרופה 1-2 דקות להגיע למחזור המרכזי

עירוי תוך-גרמי

רקע אנטומי



תמונה 25.33 עירוי תוך-גרמי

העצם בגופו של האדם אינה מבנה קשיח בלבד. תוכנה הפנימי הוא רקמה ספוגית עשירה בתאים שמייצרים את תאי הדם השונים; רקמה זו נקראת מח העצם. כל עצם בגוף מקבלת את אספקת הדם שלה מדם שנכנס אל תוך מח העצם ומספק דם לתאי העצם מבפנים החוצה. בעצמות הארוכות הגדולות שבגוף, עצם הירך (femur), השוק והזרוע, יש כלי דם גדולים במיוחד.

היתרונות והחסרונות של עירוי תוך-גרמי

יתרונות החדרת עירוי תוך-גרמי

- מאפשר הזרקת תרופות כשאין אפשרות לגישה תוך-ורידית
- מאפשר הזלפת נוזלים כשאין אפשרות לגישה תוך-ורידית

חסרונות החדרת עירוי תוך-גרמי

- הפעולה דורשת מיומנות נוספת
- הפעולה מכאיבה
- סכנת זיהום מקומי מוגברת
- אין להחזיר עירוי לגפה שנפגעה או נשברה שכן זרימת הדם שבגפה זו עלולה להיפגע.

החדרת עירוי תוך־גרמי

- כדי להחדיר עירוי תוך־גרמי משתמשים במחט גדולה - 16/18 g או במחט ייעודית לפעולה זו.
- מקום ההחדרה הוא בדרך כלל בשוק, 1-3 ס"מ מתחת לבליטת קצה עצם השוק (טיביה, שוקה, tibia), שמרכיבה את הברך.
- מחטאים היטב אזור זה באלכוהול או בתכשיר חיטוי אחר כמו בכל פעולה פולשנית.
- ההחדרה היא לתוך עצם השוק הגדולה (טיביה, שוקה, tibia) במקום שצוין לעיל ובזווית כלפי מטה (כ־60°) כאשר חוד המחט פונה לעבר צידה התחתון של עצם השוק הגדולה (הקרסול).
- מכניסים את המחט תוך כדי סיבוב המחט ולחץ מתמשך כלפי העצם.
- מחדירים את המחט עד לנקודה שבה אפשר לקדמה ללא התנגדות. נקודה זו מציינת את החדירה למח העצם.
- אפשר לוודא מיקום נכון על ידי אחת מן הפעולות האלה:
 - שאיבת תוכן מח העצם במזרק
 - רואים זרימת נוזלים בחופשיות לתוך המחט
 - המחט יציבה במקומה ללא צורך בתמיכה ידנית בה

ההתוויות לביצוע

- כאשר שני ניסיונות לחדור לווריד נכשלו במקרים שבהם יש צורך דחוף בהחדרת נוזלים או תרופות, כגון:
- דום לב
 - הלם תת־נפחי
 - התכווצויות ממושכות וקבועות (status epilepticus, static seizures)
 - פסיכופסיוס

התוויות הנגד

- חבלה או שבר בגפה או כוויה באזור
- התדלדלות העצם (osteoporosis)

ציוד נדרש

- חומר חיטוי
- מחט תוך־גרמית המתאימה לגילו של המטופל
- ציוד להרדמה מקומית (אם אין את מזרק ה־JET האוטומטי)
- ציוד לעירוי
- ציוד לחבישה וקיבוע

סדר הפעולות בביצוע

- (1) מוודאים שאי אפשר לחדור לווריד פריפרי או מרכזי
- (2) מכינים את הציוד הנדרש
- (3) בוחרים את האזור. המחט תוחדר בחלק הקדמי השטוח של העצם, 2-3 ס"מ (כ-2 אצבעות) מתחת לפיקת הברך, לכיוון פנים (tibial tuberosity), זוהי בליטה גרמית בחלק הקדמי המקורב של עצם השוק שאליה מתחבר גיד הפיקה)
- (4) מחטאים את המקום
- (5) אוחזים את המחט בזווית של 90 מעלות לעומת משטח העצם
- (6) דוחפים את המחט עד שלפתע מפסיקים להרגיש התנגדות של העצם
- (7) מוודאים מיקום על ידי שאיבה במזרק
- (8) לא תמיד אפשר לשאוב מח עצם, כך שאין לסמוך על בדיקה זו. בכל מקרה, המחט אמורה להיות יציבה, בניצב לעצם, ללא תמיכה
- (9) מזריקים מים פיזיולוגיים כדי לשטוף. על הנוזלים להיכנס בקלות, ללא התנגדות
- (10) מחברים סט לעירוי
- (11) מקבעים את המחט והסט
- (12) חובשים בצורה סטרילית

מימוניות נתיב אוויר

אינטובציה (צנר)

אינטובציה היא פעולה פולשנית, לא סטרילית, שבמהלכה מוחדר צינור, טובוס, אל קנה הנשימה. אם יש לבצע אינטובציה לנפגע החשוד כפגוע עמוד שדרה (עמ"ש) או עמוד שדרה צווארי (עמ"ש"צ) יש להיעזר באיש צוות שיקבע את הראש וימנע את הטיית ראשו של הנפגע לאחר.

מטרות ויתרונות

- (1) אבטחת נתיב אוויר מוחלטת
- (2) הנשמה ב-100% חמצן
- (3) הנשמה בלחץ חיובי
- (4) מתן תרופות מסוימות בהיעדר וריד פתוח
- (5) אינטובציה מניעתית - בכוויות בדרכי הנשימה או בצקת בחלל הלוע
- (6) תיקון אוורור לקוי